





in
vima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL		VIGILANCIA	
FORMATO REPORTE DE SOSPECHA DE EVENTOS ADVERSOS A MEDICAMENTOS - FOREAM			
Código: IVC-VIG-FM026	Versión: 01	Fecha de Emisión: 05/04/2016	Página 1 de 3

1. INFORMACIÓN DEL REPORTANTE				
Fecha de notificación	Origen del reporte		Nombre de la Institución donde ocurrió el evento	Código PNF
	Departamento – Municipio			
2023-05-23	BOGOTA D.C - BOGOTA		DOMICILIO	
Nombre del Reportante primario	Nombre del Paciente o Acudiente	Consecutivo	Profesión del reportante primario	
Ana Yeimi Sanchez Lozano	ACUDIENTE	79RCuv6r	ENFERMERA	
Correo electrónico institucional del reportante primario				
asanchez@encontactopeoplemarketing.com				

2. INFORMACIÓN DEL PACIENTE						
Fecha de nacimiento del paciente	Edad del paciente en el momento del EA	Documento de identificación del paciente	Iniciales del paciente	Sexo	Peso	Talla
	Edad – Años/Meses/ días	CC TI RC NUIP Cód. Lab Otro S/I		M F S/I	(Kg)	(cm)
1942-11-22	80	C.C - 41341703	LEPDH	F	44	150
Diagnóstico principal y otros diagnósticos:						
Acromegalia						



INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL		VIGILANCIA	
FORMATO REPORTE DE SOSPECHA DE EVENTOS ADVERSOS A MEDICAMENTOS - FOREAM			
Código: IVC-VIG-FM026	Versión: 01	Fecha de Emisión: 05/04/2016	Página 1 de 3

3. INFORMACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS								
Registre todos los medicamentos utilizados y marque con una “S” el (los) sospechoso(s), con una “C” el (los) concomitantes y con una “I” las interacciones.								
S/C/I	Medicamento (Denominación Común Internacional o Nombre genérico)	Indicación	Dosis	Unidad de medida	Vía de administración	Frecuencia de administración	Fecha de inicio	Fecha de finalización
S	LANREOTIDE /SOMATULINE	ACROMEGALIA	120	MG	SUBCUTÁNEO PROFUNDO	CADA 30 DIAS	01/01/2014	23/01/2023
C	ESOMEPRAZOL	PROTECTOR MUCOSA GASTRICA	20	MG	ORAL	CADA 24 HORAS	SIN INFORMACION	ACTUALMENTE
C	LOSARTAN	HIPERTENSION	50	MG	ORAL	CADA 12 HORAS	SIN INFORMACION	ACTUALMENTE
C	METOPROLOL	HIPERTENSION	50	MG	ORAL	CADA 24 HORAS	SIN INFORMACION	ACTUALMENTE
C	METFORMINA	MANEJO DE LA DIABETES	1000	MG	ORAL	CADA 12 HORAS	SIN INFORMACION	ACTUALMENTE
C	VILDAGLIPTINA	MANEJO DE LA DIABETES	50	MG	ORAL	CADA 12 HORAS	SIN INFORMACION	ACTUALMENTE
C	CABERGOLINA	CONTROL DE LA HORMONA DE CRECIMIENTO	0,5	MG	ORAL	CADA 48 HORAS	SIN INFORMACION	ACTUALMENTE
C	RIVASTIGMINA	CONTROL ALZHEIMER	4,6	MG	TRANSDERMICO	CADA 24 HORAS	SIN INFORMACION	ACTUALMENTE
C	VALERIANA	MANEJO DE LOS NERVIOS	10	GOTAS	ORAL	CADA 12 HORAS	SIN INFORMACION	ACTUALMENTE
C	METOCLOLPRAMIDA	ANTIEMÉTICO	10	MG	ORAL	CADA 8 HORAS	SIN INFORMACION	ACTUALMENTE
S	LANREOTIDE /SOMATULINE	ACROMEGALIA	120	MG	SUBCUTÁNEO PROFUNDO	CADA 28 DIAS	16/05/2023	ACTUALMENTE
Información comercial del medicamento sospechoso								
Titular del Registro sanitario			Nombre Comercial		Registro sanitario		Lote	
			SOMATULINE		SIN INFORMACION		SIN INFORMACION	



INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL		VIGILANCIA	
FORMATO REPORTE DE SOSPECHA DE EVENTOS ADVERSOS A MEDICAMENTOS - FOREAM			
Código: IVC-VIG-FM026	Versión: 01	Fecha de Emisión: 05/04/2016	Página 1 de 3

4. INFORMACIÓN DEL EVENTO ADVERSO	
Fecha de Inicio del Evento Adverso: 2023-05-23	Evento adverso: REINICIO DE TERAPIA, FATIGA, PERDIDA DE PESO, PERDIDA DEL APETITO
Descripción y análisis del Evento Adverso: AL COMUNICARSE CON ACUDIENTE REFIERE QUE LA PACIENTE HA ESTADO PRESENTANDO FATIGA, PERDIDA DE PESO, NO MENCIONA CUANTO Y PERDIDA DEL APETITO. EVENTO YA REPORTADO EL 04/04/2023 SE REPORTE REINICIO DE TERAPIA	Desenlace del evento (Marcar con una X) Recuperado / Resuelto sin secuelas Recuperado / Resuelto con secuelas ☒ Recuperando / Resolviendo No recuperado / No resuelto Fatal Desconocido Seriedad (Marcar con X) Produjo o prolongó hospitalización Anomalía congénita Amenaza de vida Muerte (Fecha: _____) Produjo discapacidad o incapacidad permanente / condición médica importante ☒ Ninguno

	Si	No	No sabe
¿El evento se presentó después de administrar el medicamento?		X	
¿Existen otros factores que puedan explicar el evento (medicamento, patologías, etc.)?	X		
¿El evento desapareció al disminuir o suspender el medicamento sospechoso?			X
¿El paciente ya había presentado la misma reacción al medicamento sospechoso?			X
¿Se puede ampliar la información del paciente relacionando con el evento?	X		